

Амиодарон

Антиаритмик III класса · обладает свойствами всех четырёх классов по Вогану — Уильямсу

ФОРМА ВЫПУСКА

5 % · 3 мл = **150 мг**
50 мг/мл

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Основной эффект — блокада калиевых каналов фазы 3 реполяризации: удлинение потенциала действия и рефрактерного периода. Дополнительно: блокада натриевых каналов (свойства I класса), неконкурентная β-адреноблокада (II класс), блокада кальциевых каналов (IV класс). Вызывает вазодилатацию (частично обусловлена растворителем — полисорбатом 80). Период полувыведения 40-55 суток.

ДОЗИРОВАНИЕ ПО АЛГОРИТМАМ

Клиническая ситуация	Доза	Путь
ФЖ / ЖТ без пульса (после 3-го разряда)	300 мг (6 мл)	в/в струйно
Сохраняющаяся ФЖ / ЖТ без пульса (однократно)	150 мг (3 мл)	в/в
Ширококомплексная тахикардия, стабильная гемодинамика	150-300 мг (3-6 мл) в декстрозе 5 % до 20 мл	в/в струйно
Ширококомплексная тахикардия, нестабильная гемодинамика (фоновая инфузия до ЭИТ)	150 мг (3 мл) в декстрозе 5 % — 250 мл	в/в капельно
Узкокомплексная пароксизмальная тахикардия при ХСН	300-450 мг (6-9 мл) в декстрозе 5 % — 250 мл	в/в капельно
ФП < 48 ч (при противопоказаниях к пропafenону или прокаинамиду)	5 мг/кг (макс. 450 мг, 9 мл) в декстрозе 5 % — 250 мл, ожидание эффекта до 20 мин	в/в капельно
Такисистолия ФП при застойной СН без гипотензии	300-450 мг (6-9 мл) в декстрозе 5 % — 20 мл через шприцевой дозатор за 20 мин	в/в
Дети: такисистолия, WPW	5 мг/кг (0,1 мл/кг) в декстрозе 5 %, инфузия не менее 30 мин	в/в капельно
Пируэтная тахикардия (torsades de pointes)	противопоказан — назначается магния сульфат	

Растворитель: только декстроза 5 %. Хлорид натрия 0,9 % вызывает образование осадка. Минимальная концентрация раствора ≥ 0,6 мг/мл. Капельную инфузию проводить через шприцевой дозатор (полисорбат искажает размер капли).

НАСОС 31-Р Дети: 150 мг (3 мл) + 47 мл декстрозы 5 % = 50 мл (3 мг/мл); ступени 5, 10, 15 мкг/кг/мин (прил. 40). Взрослые: 150 мг (3 мл) + 17 мл декстрозы 5 % = 20 мл (7,5 мг/мл) — для болюса через насос.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

- Пируэтная тахикардия — амиодарон сам удлиняет интервал QT
- Сочетание с бета-адреноблокаторами или верапамилом — риск тяжёлой брадикардии, АВ-блокады, гипотензии
- Одновременный приём препаратов, удлиняющих QT (макролиды, антипсихотики) — риск пируэтной тахикардии

- Новорождённые: растворитель содержит бензиловый спирт (синдром «gasping»)

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ТАКТИКА

- Болюсное введение вне остановки кровообращения сопряжено с риском тяжёлой гипотензии; вне СЛР вводить за 20 минут
- Повышает концентрацию дигоксина вдвое; усиливает действие варфарина (рост МНО)
- Период полувыведения до 100 суток: пациент, прекративший приём месяц назад, по-прежнему находится под действием препарата
- Инфузионную линию промывать декстрозой 5 %; не смешивать с другими препаратами в одном шприце